PCR Pediátrica · Cartão de Plantão

Para consultar à beira do leito; confira no protocolo do serviço

Reconhecer [SBC]

Inconsciente + apneia/gasping + sem pulso (braquial/carotídeo) em ≤ 10 s. **FC < 60 + má perfusão** apesar de O2 e ventilação: comprimir. Ajuda: SAMU 192.

RCP [SBC] [ERC]

Frequência	100–120/min, retorno completo
Profundidade	⅓ AP · ~4 cm lactente · ~5 cm criança
Relação SBC	30:2 (1) · 15:2 (2)
Via avançada	SBC 10/min · ERC 25/20/15/10 (lact/1–8/8–12/>12)
O2	100% durante a RCP
Acesso	IV ou IO; IO antes de endotraqueal

Choque [SBC] [ERC]

FV/TV sem pulso: SBC **2–4 J/kg** (até 10). ERC **4 J/kg**; refratária até 8 J/kg (máx. 360 J). Após cada choque, RCP já por 2 min e só então reavaliar o ritmo. DEA: atenuador < 8 anos ou < 25 kg.

Após o RCE [ERC] [RCUK]

SpO2 94–98% · PaCO2 normal · PAS e PAM > p10 · controle térmico ≥ 24 h, sem febre ≥ 72 h · glicose · UTI.

Drogas na PCR [SBC] [ERC]

Adrenalina	**0,01 mg/kg** = 0,1 mL/kg da 0,1 mg/mL; máx. 1 mg; 3–5 min (ERC 4 min)
Amiodarona	**5 mg/kg bolus**; ERC: após 3º choque (máx. 300) e 5º (máx. 150)
Lidocaína	1 mg/kg (alternativa)
Magnésio	25–50 mg/kg (máx. 2 g) se torsades
Glicose	Só se hipoglicemia: ERC SG 10% 2 mL/kg · SBC 5–10 mL/kg

Bradicardia com pulso [SBC]

Oxigenar e ventilar. FC < 60 + má perfusão: comprimir. Adrenalina 0,01 mg/kg. Vagal ou BAV: **atropina 0,02 mg/kg** (criança 0,1–0,5 mg; adolescente 0,1–1 mg).

TSV [SBC] [ERC]

Estável: vagal → **adenosina 0,1 mg/kg** (máx. 6) rápido + flush → 0,2 mg/kg (máx. 12). Instável: **cardioversão sincronizada** SBC 0,5–1 → 1–2 J/kg; ERC 1 → até 4 J/kg.

4 H e 4 T [ERC]

Hipóxia · hipovolemia (10 mL/kg) · hipo/hipercalemia e metabólicos · hipotermia · trombose · pneumotórax hipertensivo · tamponamento · tóxicos.

Não fazer

Chocar assistolia · ampola 1 mg/mL em 0,1 mL/kg na veia · intubar à custa da RCP · amiodarona em bolus com pulso · cálcio e bicarbonato de rotina · O2 100% sem titular após o RCE.